

QCMs d'évaluation

Sujet 65

Les syndromes coronariens aigus

Pr Leila ABID

Pr Ag Amine BAHLOUL -

Faculté de médecine de Sfax

Objectif 1, 2

- Décrire l'anatomie de la vascularisation artérielle cardiaque.
- Expliquer les mécanismes et les conséquences physiopathologiques des syndromes coronariens aigus.

Q1: Concernant la vascularisation coronaire, quelles sont les propositions vraies?

- A. L'occlusion de l'artère interventriculaire antérieure est responsable d'un infarctus antéroseptal
- B. La circonflexe chemine dans le sillon auriculo-ventriculaire droit
- C. La vascularisation coronaire est de type terminale
- D. Dans 85% des cas la dominance coronaire est de type gauche
- E. La coronaire droite vascularise essentiellement la paroi diaphragmatique du VG et la paroi inférolatérale du VD

Q1: Concernant la vascularisation coronaire, quelles sont les propositions vraies?

- A. L'occlusion de l'artère interventriculaire antérieure est responsable d'un infarctus antéroseptal
- B. La circonflexe chemine dans le sillon auriculo-ventriculaire droit
- C. La vascularisation coronaire est de type terminale
- D. Dans 85% des cas la dominance coronaire est de type gauche
- E. La coronaire droite vascularise essentiellement la paroi diaphragmatique du VG et la paroi inférolatérale du VD

Q2: A Propos de la vascularisation coronaire :

- A. La vascularisation cardiaque est assurée par 2 artères coronaires : droite et gauche qui s'anastomosent au niveau du sillon interventriculaire
- B. L'artère coronaire gauche se divise en deux branches : l'interventriculaire antérieure pour la paroi antérieure et l'interventriculaire postérieure pour la paroi postérieure
- C. L'artère circonflexe , naît du sinus de valsalva postérieur et vascularise la paroi latérale du ventricule gauche
- D. L'artère interventriculaire antérieure descend dans le sillon interventriculaire et se termine dans la partie inférieure du sillon interventriculaire.
- E. L'artère coronaire droite donne une branche nodale et vascularise l'essentiel du tissu nodal

Q2: A Propos de la vascularisation coronaire :

- A. La vascularisation cardiaque est assurée par 2 artères coronaires : droite et gauche qui s'anastomosent au niveau du sillon interventriculaire
- B. L'artère coronaire gauche se divise en deux branches : l'interventriculaire antérieure pour la paroi antérieure et l'interventriculaire postérieure pour la paroi postérieure
- C. L'artère circonflexe , naît du sinus de valsalva postérieur et vascularise la paroi latérale du ventricule gauche
- D. L'artère interventriculaire antérieure descend dans le sillon interventriculaire et se termine dans la partie inférieure du sillon interventriculaire.
- E. L'artère coronaire droite donne une branche nodale et vascularise l'essentiel du tissu nodal

Q3: Trois semaines après un infarctus du myocarde, on retrouve à l'examen histologique :

- A. De nombreux macrophages
- B. Une nécrose de coagulation
- C. Une fibrose cicatricielle
- D. Un Infiltrat inflammatoire riche en lymphocytes
- E. Aucune anomalie histologique

Q3: Trois semaines après un infarctus du myocarde, on retrouve à l'examen histologique :

- A. De nombreux macrophages
- B. Une nécrose de coagulation
- C. Une fibrose cicatricielle
- D. Un Infiltrat inflammatoire riche en lymphocytes
- E. Aucune anomalie histologique

Q4: Deux heures après un infarctus du myocarde, on retrouve à l'examen histologique :

- A. De nombreux macrophages
- B. Un Infiltrat inflammatoire riche en polynucléaires neutrophiles
- C. Une fibrose
- D. Une nécrose des cardiomyocytes
- E. Aucune anomalie histologique

Q4: Deux heures après un infarctus du myocarde, on retrouve à l'examen histologique :

- A. De nombreux macrophages
- B. Un Infiltrat inflammatoire riche en polynucléaires neutrophiles
- C. Une fibrose
- D. Une nécrose des cardiomyocytes
- E. Aucune anomalie histologique

Q5: Toutes les propositions suivantes concernant la rupture d'une plaque endocoronaire sont exactes sauf une :

- A. Elle concerne principalement les plaques instables riches en lipides.
- B. La constitution d'un thrombus endocoronaire est la conséquence quasi inéluctable de la rupture ou l'érosion de plaque.
- C. Seules les plaques très sténosantes (> à 70%) sont susceptibles de se rompre.
- D. La traduction clinique de la rupture de plaques peut être une mort subite.
- E. La prescription d'Aspirine réduit la sévérité de la thrombose endocoronaire consécutive à la rupture de plaques.

Q5: Toutes les propositions suivantes concernant la rupture d'une plaque endocoronaire sont exactes sauf une :

- A. Elle concerne principalement les plaques instables riches en lipides.
- B. La constitution d'un thrombus endocoronaire est la conséquence quasi inéluctable de la rupture ou l'érosion de plaque.
- C. Seules les plaques très sténosantes (> à 70%) sont susceptibles de se rompre.
- D. La traduction clinique de la rupture de plaques peut être une mort subite.
- E. La prescription d'Aspirine réduit la sévérité de la thrombose endocoronaire consécutive à la rupture de plaques.

Q6: Une plaque athéromateuse vulnérable est formée de :

- A. Chape fibreuse épaisse
- B. Gros cœur lipidique
- C. Densité élevé en cellules musculaires lisses
- D. Substrat inflammatoire important.
- E. Calcifications importantes

Q6: Une plaque athéromateuse vulnérable est formée de :

- A. Chape fibreuse épaisse
- B. Gros cœur lipidique
- C. Densité élevé en cellules musculaires lisses
- D. Substrat inflammatoire important.
- E. Calcifications importantes

Objectif 3, 6

- Etablir le diagnostic positif d'un syndrome coronarien aigu à partir des données de l'anamnèse, de l'électrocardiogramme et de la biologie.
- Enumérer les différents facteurs de risque cardiovasculaire des syndromes coronaires aigus.

Q7: Dans quelles dérivations ECG se manifeste un infarctus du myocarde par occlusion aiguë de l'artère interventriculaire antérieure proximale :

- A. D2 D3 VF
- B. V1 V2 V3 V4
- C. V7 V8 V9
- D. D1 VL
- E. V5 V6 V7

Q7: Dans quelles dérivations ECG se manifeste un infarctus du myocarde par occlusion aiguë de l'artère interventriculaire antérieure proximale :

- A. D2 D3 VF
- B. V1 V2 V3 V4
- C. V7 V8 V9
- D. D1 VL
- E. V5 V6 V7

Q8: Quelles sont les propositions exactes concernant l'angor instable ?

- A. Son mécanisme est du généralement à une rupture de plaque coronaire
- B. Les taux sanguins de Troponine sont élevés surtout dans les formes les plus graves.
- C. Un électrocardiogramme normal à l'admission du patient exclut le diagnostic .
- D. Il n ' y a habituellement pas d ' indication au traitement thrombolytique dans l ' angor instable.
- E. Un traitement ambulatoire est possibles pour les formes non graves

Q8: Quelles sont les propositions exactes concernant l'angor instable ?

- A. Son mécanisme est du généralement à une rupture de plaque coronaire
- B. Les taux sanguins de Troponine sont élevés surtout dans les formes les plus graves.
- C. Un électrocardiogramme normal à l'admission du patient exclut le diagnostic .
- D. Il n ' y a habituellement pas d ' indication au traitement thrombolytique dans l ' angor instable.
- E. Un traitement ambulatoire est possibles pour les formes non graves

Q9: A propos de l'infarctus du myocarde inférieur, quelles sont les propositions exactes?

- A. Les signes électriques directs sont observés dans les dérivations précordiales (V1, V2, V3)
- B. Il correspond habituellement à une occlusion de l'artère circonflexe
- C. Il peut se compliquer de rupture du septum interventriculaire
- D. Il peut se compliquer d'un syndrome péricardique aigu plusieurs semaines après le début de la nécrose
- E. Il se complique souvent d'une insuffisance mitrale par dysfonction du pilier postérieur

Q9: A propos de l'infarctus du myocarde inférieur, quelles sont les propositions exactes?

- A. Les signes électriques directs sont observés dans les dérivations précordiales (V1, V2, V3)
- B. Il correspond habituellement à une occlusion de l'artère circonflexe
- C. Il peut se compliquer de rupture du septum interventriculaire
- D. Il peut se compliquer d'un syndrome péricardique aigu plusieurs semaines après le début de la nécrose
- E. Il se complique souvent d'une insuffisance mitrale par dysfonction du pilier postérieur

Objectif 5, 7

- Etablir les diagnostics différentiels d'un syndrome coronarien aigu.
- Décrire les modalités évolutives et les complications précoces et tardives d'un syndrome coronarien aigu.

Q10: Monsieur Ali, âgé de 70 ans, est hospitalisé pour un syndrome coronaire aigu avec sus-décalage de ST étendu cliniquement et électriquement au ventricule droit . A l'examen clinique : FC = 120 bpm, FR = 16/min, TA = 80 /60 mmHg. Turgescence des veines jugulaires. En dehors de la revascularisation coronaire, quels traitements administrez vous ?

- A. Betabloquants par voie orale
- B. Dérivés nitrés en perfusion intraveineuse à la seringue électrique.
- C. Diurétiques par voie intraveineuse.
- D. Inotropes positifs en perfusion intraveineuse à la seringue électrique
- E. Remplissage vasculaire.

Q10: Monsieur Ali, âgé de 70 ans, est hospitalisé pour un syndrome coronaire aigu avec sus-décalage de ST étendu cliniquement et électriquement au ventricule droit . A l'examen clinique : FC = 120 bpm, FR = 16/min, TA = 80 /60 mmHg. Turgescence des veines jugulaires. En dehors de la revascularisation coronaire, quels traitements administrez vous ?

- A. Betabloquants par voie orale
- B. Dérivés nitrés en perfusion intraveineuse à la seringue électrique.
- C. Diurétiques par voie intraveineuse.
- D. Inotropes positifs en perfusion intraveineuse à la seringue électrique
- E. Remplissage vasculaire.

Q 11: Les complications suivantes peuvent emmailler le cours d'un infarctus inférieur lié à une occlusion de la coronaire droite

- A. Œdème aigu du poumon.
- B. Insuffisance mitrale aiguë.
- C. Insuffisance aortique aiguë
- D. Trouble du rythme ventriculaire.
- E. Extension de l'infarctus au ventricule droit.

Q 11: Les complications suivantes peuvent emmailler le cours d'un infarctus inférieur lié à une occlusion de la coronaire droite

- A. Œdème aigu du poumon.
- B. Insuffisance mitrale aiguë.
- C. Insuffisance aortique aiguë
- D. Trouble du rythme ventriculaire.
- E. Extension de l'infarctus au ventricule droit.

Q12: En dehors de la revascularisation coronaire, quels traitements sont prohibés dans un SCA ST+ avec extension au ventricule droit?

- A. Dérivés nitrés à la seringue électrique
- B. remplissage vasculaire
- C. inhibiteurs calciques
- D. bêtabloquants
- E. inotrope positif

Q12: En dehors de la revascularisation coronaire, quels traitements sont prohibés dans un SCA ST+ avec extension au ventricule droit?

- A. Dérivés nitrés à la seringue électrique
- B. remplissage vasculaire
- C. inhibiteurs calciques
- D. bêtabloquants
- E. inotrope positif

Q13: Concernant le BAV associé à l'infarctus du myocarde inférieur, quelles sont les réponses exactes ?

- A. Est souvent de siège nodal
- B. Est de résolution spontanée après reperfusion.
- C. Est de mécanisme vagal
- D. Présente un taux de mortalité plus élevé que le BAV associé à l'IDM antérieur
- E. Nécessite souvent une sonde d'entraînement électro-systolique

Q13: Concernant le BAV associé à l'infarctus du myocarde inférieur, quelles sont les réponses exactes ?

- A. Est souvent de siège nodal
- B. Est de résolution spontanée après reperfusion.
- C. Est de mécanisme vagal
- D. Présente un taux de mortalité plus élevé que le BAV associé à l'IDM antérieur
- E. Nécessite souvent une sonde d'entraînement électro-systolique

Q14: Concernant le BAV associé à l'infarctus du myocarde antérieur, quelles sont les réponses exactes ?

- A. Est souvent de siège infra-hissien
- B. Est souvent de résolution spontanée
- C. Est de mécanisme vagal
- D. Présente un taux de mortalité plus élevé que le BAV associé à l'IDM antérieur
- E. Répond à l'atropine

Q14: Concernant le BAV associé à l'infarctus du myocarde antérieur, quelles sont les réponses exactes ?

- A. Est souvent de siège infra-hissien
- B. Est souvent de résolution spontanée
- C. Est de mécanisme vagal
- D. Présente un taux de mortalité plus élevé que le BAV associé à l'IDM antérieur
- E. Répond à l'atropine

Q 15: La survenue d'une salve de rythme idio-ventriculaire accéléré (RIVA) à la phase aiguë d'un infarctus du myocarde

- A. Est un élément de mauvais pronostic
- B. Traduit un infarctus étendu
- C. Impose un traitement anti-arythmique systématique
- D. Est une indication de traitement digitalique
- E. Aucune des réponses ci-dessus n'est exacte

Q 15: La survenue d'une salve de rythme idio-ventriculaire accéléré (RIVA) à la phase aiguë d'un infarctus du myocarde

- A. Est un élément de mauvais pronostic
- B. Traduit un infarctus étendu
- C. Impose un traitement anti-arythmique systématique
- D. Est une indication de traitement digitalique
- E. Aucune des réponses ci-dessus n'est exacte

Q 16: La péricardite aiguë du post infarctus (syndrome de dressler)

- A. Survient précocement après l'infarctus (dans la première semaine)
- B. Son mécanisme est immunologique secondairement à la nécrose myocardique.
- C. Est souvent en relation avec une reperfusion tardive ou une nécrose étendue.
- D. Répond favorablement au traitement anti-inflammatoire
- E. Nécessite souvent un traitement par les corticoïdes

Q 16: La péricardite aiguë du post infarctus (syndrome de dressler)

- A. Survient précocement après l'infarctus (dans la première semaine)
- B. Son mécanisme est immunologique secondairement à la nécrose myocardique.
- C. Est souvent en relation avec une reperfusion tardive ou une nécrose étendue.
- D. Répond favorablement au traitement anti-inflammatoire
- E. Nécessite souvent un traitement par les corticoïdes

Q17:Quelles sont les complications aiguës possibles des SCA ST+ antérieurs?

- A. Insuffisance cardiaque gauche
- B. BAV complet par dysfonction du nœud auriculoventriculaire
- C. Insuffisance mitrale par restriction de la petite valve
- D. Rupture septale
- E. Syndrome de Dressler

Q17:Quelles sont les complications aiguës possibles des SCA ST+ antérieurs?

- A. Insuffisance cardiaque gauche
- B. BAV complet par dysfonction du nœud auriculoventriculaire
- C. Insuffisance mitrale par restriction de la petite valve
- D. Rupture septale
- E. Syndrome de Dressler

Objectif 4, 9

- Stratifier le risque cardiovasculaire d'un patient ayant un syndrome coronarien aigu.
- Planifier la stratégie thérapeutique d'un syndrome coronarien aigu ST (-) en précisant les indications du traitement pharmacologique et la place de la coronarographie, en fonction de la gravité.

Q 18: Parmi les suivants, quels critères justifient la réalisation d'une coronarographie en urgence dans le syndrome coronaire aigu sans sus décalage de ST (SCA ST-) ?

- A. récurrence d'angor sous traitement médical maximal
- B. fibrillation auriculaire
- C. antécédent de pontage aorto-coronaire
- D. instabilité hémodynamique
- E. insuffisance rénale

Q 18: Parmi les suivants, quels critères justifient la réalisation d'une coronarographie en urgence dans le syndrome coronaire aigu sans sus décalage de ST (SCA ST-) ?

A. récurrence d'angor sous traitement médical maximal

B. fibrillation auriculaire

C. antécédent de pontage aorto-coronaire

D. instabilité hémodynamique

E. insuffisance rénale

Q 19: Parmi les suivants, quels critères justifient la réalisation d'une coronarographie dans les 24 heures dans le SCA ST- ?

- A. Récidive d'angor sous traitement médical maximal
- B. Modifications électriques type ondes T négatives sous traitement médical
- C. Antécédent d'angioplastie coronaire il y a 2 mois
- D. élévation des troponines
- E. Score de GARCE > 109

Q 19: Parmi les suivants, quels critères justifient la réalisation d'une coronarographie dans les 24 heures dans le SCA ST- ?

- A. Récidive d'angor sous traitement médical maximal
- B. Modifications électriques type ondes T négatives sous traitement médical
- C. Antécédent d'angioplastie coronaire il y a 2 mois
- D. élévation des troponines
- E. Score de GARCE > 109

Objectif 8

- Planifier la prise en charge thérapeutique initiale des syndromes coronariens aigus ST (+).

Q20: Quelles sont les indications à réaliser une angioplastie primaire dans le syndrome coronarien aigu avec sus-décalage de ST ?

- A. Délai estimé entre le premier contact médical et le cathétérisme de l'artère occluse inférieure à 120 minutes.
- B. Délai estimé entre le début de la douleur et le cathétérisme de l'artère occluse inférieure à 120 minutes.
- C. Délai estimé entre le premier contact médical et l'arrivée en soins intensifs cardiologiques inférieure à 120 minutes.
- D. Délai estimé entre le début de la douleur et l'arrivée en soins intensifs cardiologiques inférieure à 120 minutes.
- E. Dans les 12 premières heures suivant le début de la douleur thoracique.

Q20: Quelles sont les indications à réaliser une angioplastie primaire dans le syndrome coronarien aigu avec sus-décalage de ST ?

- A. Délai estimé entre le premier contact médical et le cathétérisme de l'artère occluse inférieure à 120 minutes.
- B. Délai estimé entre le début de la douleur et le cathétérisme de l'artère occluse inférieure à 120 minutes.
- C. Délai estimé entre le premier contact médical et l'arrivée en soins intensifs cardiologiques inférieure à 120 minutes.
- D. Délai estimé entre le début de la douleur et l'arrivée en soins intensifs cardiologiques inférieure à 120 minutes.
- E. Dans les 12 premières heures suivant le début de la douleur thoracique.

Objectif 10, 11

- Décrire le mécanisme d'action, les indications, les contre-indications, les modalités d'administration et les effets indésirables des fibrinolytiques.
- Décrire le mécanisme d'action et les principaux effets indésirables des différentes classes médicamenteuses utilisées dans le traitement des syndromes coronariens aigus.

Q 21: Quels médicaments parmi les suivants peuvent faire partie de la prise en charge initiale du syndrome coronaire aigu sans sus décalage de ST ?

- A. Aspirine 250 mg par voie intraveineuse directe
- B. Prasugrel 60 mg par voie orale chez un patient au antécédant d'AIT
- C. Ticagrelor 180 mg par voie orale chez un patient au antécédant d'AVC ischémique
- D. Fondaparinux 2,5 mg, 1 injections sous cutané quel que soit le risque ischémique
- E. HNF 50 mg par voie intraveineuse suivie par HBPM 1mg/Kg/12h en sous cutané

Q 21: Quels médicaments parmi les suivants peuvent faire partie de la prise en charge initiale du syndrome coronaire aigu sans sus décalage de ST ?

- A. Aspirine 250 mg par voie intraveineuse directe
- B. Prasugrel 60 mg par voie orale chez un patient au antécédant d'AIT
- C. Ticagrelor 180 mg par voie orale chez un patient au antécédant d'AVC ischémique
- D. Fondaparinux 2,5 mg, 1 injections sous cutané quel que soit le risque ischémique
- E. HNF 50 mg par voie intraveineuse suivie par HBPM 1mg/Kg/12h en sous cutané

Q22: Quelles sont les classes pharmacologiques anti-thrombotiques utilisables lors de la prise en charge initiale d'un syndrome coronaire aigu avec sus décalage de ST:

- A. Aspirine
- B. Rivaroxaban
- C. Ticagrelor
- D. Héparine de bas poids moléculaire
- E. Fondaparinux

Q22: Quelles sont les classes pharmacologiques anti-thrombotiques utilisables lors de la prise en charge initiale d'un syndrome coronaire aigu avec sus décalage de ST:

- A. Aspirine
- B. Rivaroxaban
- C. Ticagrelor
- D. Héparine de bas poids moléculaire
- E. Fondaparinux

Q 23: Quels éléments parmi les suivants peuvent faire partie de la prise en charge initiale (dans les 24h) du syndrome coronaire aigu avec sus décalage de ST ?

- A. Aspirine 250 mg par voie intraveineuse directe
- B. Anticoagulation par voie Orale
- C. Bêtabloquants par voie intra-veineuse
- D. Inhibiteur de l'enzyme de conversion per os
- E. Statine à forte dose per os systématique

Q 23: Quels éléments parmi les suivants peuvent faire partie de la prise en charge initiale (dans les 24h) du syndrome coronaire aigu avec sus décalage de ST ?

- A. Aspirine 250 mg par voie intraveineuse directe
- B. Anticoagulation par voie Orale
- C. Bêtabloquants par voie intra-veineuse
- D. Inhibiteur de l'enzyme de conversion per os
- E. Statine à forte dose per os systématique

Q 24: La thrombolyse par le tenecteplase (Métalyse)

- A. Est administrée par voie intra-artérielle
- B. Est administrée en un seul bolus
- C. Est administrée à moitié dose chez les patients âgés de plus de 75 ans
- D. La dose administrée dépend du poids du patient
- E. Peut être associée à l'héparine non fractionnée ou à l'héparine de bas poids moléculaire

Q 24: La thrombolyse par le tenecteplase (Métalyse)

- A. Est administrée par voie intra-artérielle
- B. Est administrée en un seul bolus
- C. Est administrée à moitié dose chez les patients âgés de plus de 75 ans
- D. La dose administrée dépend du poids du patient
- E. Peut être associée à l'héparine non fractionnée ou à l'héparine de bas poids moléculaire

Q 25: La thrombolyse par l'alteplase (Actilyse)

- A. Est administrée par voie intra-artérielle
- B. Est administrée en un bolus initial (15 mg) puis en perfusion continue intraveineuse
- C. Est administrée à moitié dose chez les patients âgés de plus de 75 ans
- D. La dose administrée dépend du poids du patient
- E. Peut être associée à l'héparine non fractionnée ou à l'héparine de bas poids moléculaire

Q 25: La thrombolyse par l'alteplase (Actilyse)

- A. Est administrée par voie intra-artérielle
- B. Est administrée en un bolus initial (15 mg) puis en perfusion continue intraveineuse
- C. Est administrée à moitié dose chez les patients âgés de plus de 75 ans
- D. La dose administrée dépend du poids du patient
- E. Peut être associée à l'héparine non fractionnée ou à l'héparine de bas poids moléculaire

Q 26: La thrombolyse par la streptokinase :

- A. Est administrée en un bolus initial puis en perfusion continue intraveineuse
- B. Est administrée à moitié dose chez les patients âgés de plus de 75 ans
- C. La dose administrée dépend du poids du patient
- D. Peut être associée à l'héparine non fractionnée ou à l'héparine de bas poids moléculaire
- E. Nécessite l'administration associée d'hémosuccinate d'hydrocortisone en intraveineux direct

Q 26: La thrombolyse par la streptokinase :

- A. Est administrée en un bolus initial puis en perfusion continue intraveineuse
- B. Est administrée à moitié dose chez les patients âgés de plus de 75 ans
- C. La dose administrée dépend du poids du patient
- D. Peut être associée à l'héparine non fractionnée ou à l'héparine de bas poids moléculaire
- E. Nécessite l'administration associée d'hémosuccinate d'hydrocortisone en intraveineux direct

Q 27: Les contre-indication absolus à la thrombolyse :

- A. AVC hémorragique quelque soit l'ancienneté
- B. Traumatisme ou chirurgie majeure ou chirurgie cérébrale récente (moins d'un mois)
- C. Néoplasie ou malformation vasculaire intracrânienne
- D. Saignement gastro-intestinal datant de moins 6 mois
- E. Ponction biopsie dans le dernier mois (foie, rein , ponction lombaire)

Q 27: Les contre-indication absolus à la thrombolyse :

- A. AVC hémorragique quelque soit l'ancienneté
- B. Traumatisme ou chirurgie majeure ou chirurgie cérébrale récente (moins d'un mois)
- C. Néoplasie ou malformation vasculaire intra-crânienne
- D. Saignement gastro-intestinal datant de moins 6 mois
- E. Ponction biopsie dans le dernier mois (foie, rein , ponction lombaire)

Q 28: Parmi les médicaments suivants, on peut utiliser comme antiagrégant Plaquettaire dans le traitement des syndromes coronaires aigus avec sus décalage de ST :

- A. Ticagrelor
- B. Bivalirudine
- C. Fodaparinux
- D. Clopidogrel
- E. Abciximab

Q 28: Parmi les médicaments suivants, on peut utiliser comme antiagrégant Plaquettaire dans le traitement des syndromes coronaires aigus avec sus décalage de ST :

- A. Ticagrelor
- B. Bivalirudine
- C. Fodaparinux
- D. Clopidogrel
- E. Abciximab

Objectif 13, 14

- Rédiger l'ordonnance de sortie chez un patient ayant présenté un syndrome coronarien aigu.
- Planifier la stratégie d'exploration clinique et paraclinique après chez un patient ayant présenté un syndrome coronarien aigu.

Q29: Un patient âgé de 56ans diabétique ayant présenté un syndrome coronaire et a nécessité la revascularisation coronaire avec mise d'un stent actif.

Son ordonnance de sortie doit comporter impérativement :

- A. un inhibiteur de P2Y12
- B. une statine
- C. l'Aspirine
- D. un inhibiteur calcique
- E. un anti-aldostérone

Q29: Un patient âgé de 56ans diabétique ayant présenté un syndrome coronaire et a nécessité la revascularisation coronaire avec mise d'un stent actif.
Son ordonnance de sortie doit comporter impérativement :

- A. un inhibiteur de P2Y12
- B. une statine
- C. l'Aspirine
- D. un inhibiteur calcique
- E. un anti-aldostérone

Q 30: Un patient âgé de 60 ans diabétique, ayant présenté un IDM antérieur revascularisé avec implantation d'un stent actif, la FEVG à la sortie est de 38%.

Quels traitements doivent être envisagés en absence de contre-indication?

- A. *Un bêtabloquant type Bisporolol 5 mg par jour*
- B. *Un IEC type Ramipril 5 mg par jour*
- C. Sprinolactone à la dose de 25 mg par jour
- D. Un Inhibiteur des canaux Sodium glucose urinaires (ISGLT2)
- E. Une double anti agrégation plaquettaire pour une durée de 6 mois

Q 30: Un patient âgé de 60 ans diabétique, ayant présenté un IDM antérieur revascularisé avec implantation d'un stent actif, la FEVG à la sortie est de 38%.

Quels traitements doivent être envisagés en absence de contre-indication?

- A. Un bêtabloquant type Bisporolol 5 mg par jour*
- B. Un IEC type Ramipril 5 mg par jour*
- C. Sprinolactone à la dose de 25 mg par jour*
- D. Un Inhibiteur des canaux Sodium glucose urinaires (ISGLT2)*
- E. Une double anti agrégation plaquettaire pour une durée de 6 mois

Q 31: Quels sont les objectifs thérapeutique au cours de la prise en charge tardive d'un patient diabétique victime d'un SCA ST+ revascularisé avec implantation d'un stent actif ?

- A. LDL cholestérol cible < 0.7 g/l
- B. Un indice de masse corporelle inférieur à 30 Kg/m^2
- C. Contrôle diabétique avec une HbA1C $< 8\%$ en absence d'hypoglycémie
- D. Une PAS cible < 140 mmHg mais non < 130 mmHg
- E. Une PAD cible < 80 mmHg mais non < 70 mmHg

Q 31: Quels sont les objectifs thérapeutique au cours de la prise en charge tardive d'un patient diabétique victime d'un SCA ST+ revascularisé avec implantation d'un stent actif ?

- A. LDL cholestérol cible < 0.7 g/l
- B. Un indice de masse corporelle inférieur à 30 Kg/m²
- C. Contrôle diabétique avec une HbA1C < 8% en absence d'hypoglycémie
- D. Une PAS cible < 140 mmHg
- E. Une PAD cible < 80 mmHg

Q 32: Un patient coronarien connu avec LDL cholestérol à 2 gr initialement vous consulte avec un LDL à 1.1 g/l sous statine à faible dose après 3 mois de traitement.

Quelles propositions vous paraissent correctes ?

- A. Majoration de la dose de sa statine
- B. Association de sa statine avec un fibraté
- C. Association de sa statine avec Ezetimibe (Ezetrol) si LDL cholestérol reste $> 0.55\text{g/l}$ à la dose maximale tolérée de statine
- D. la diminution de 50 % du LDL est acceptable quelque soit le taux de LDL cholestérol de base
- E. la surveillance par dosage des CPK est systématique

Q 32: Un patient coronarien connu avec LDL cholestérol à 2 gr initialement vous consulte avec un LDL à 1.1 g/l sous statine à faible dose après 3 mois de traitement.
Quelles propositions vous paraissent correctes ?

- A. Majoration de la dose de sa statine
- B. Association de sa statine avec un fibrate
- C. Association de sa statine avec Ezetimibe (Ezetrol) si LDL cholestérol reste $> 0.55\text{g/l}$ à la dose maximale tolérée de statine
- D. la diminution de 50 % du LDL est acceptable quelque soit le taux de LDL cholestérol de base
- E. la surveillance par dosage des CPK est systématique

Bonne chance